HELP_Organi_P07 — Groupe A — Audits LOT 1 à 8 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 7 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-040 — Haute — LOT 4 · SSP G4

Emplacement : LOT_4_V6_Enrichi_8plus_Partie_1_Integral.html › D4.10 › Consulter les références et leur portée ; constats L4-M08, L4-M12, L4-M59, L4-M71

Contexte : Le diagnostic de l'Addison s'appuie sur l'Endocrine Society ; l'autorisation suisse de Plenadren®, Alkindi® et Efmody® n'est pas vérifiée et le cours affirme sans source qu'Efmody® et les pompes « améliorent considérablement » la fatigue.

Question : Quels critères diagnostiques de l'insuffisance surrénalienne (cortisol basal, test au Synacthène® : dose, temps, seuils selon la méthode de dosage) recommande la source européenne la plus récente ? Plenadren®, Alkindi® et Efmody® sont-ils autorisés par Swissmedic (indication, dose) et quelle étude chiffre leur effet sur la fatigue ou la qualité de vie ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

A-041 — Haute — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2__export_GoogleDoc.html › D4.1 › point 11.B › pharmacologie 1re intention ; constats L4-M17, L4-M18, L4-M19, L4-M20, L4-M21

Contexte : Le cours associe Maltofer® au sulfate ferreux, exprime la formule de Ganzoni en g/dL, ne donne ni dose unique maximale ni surveillance de Ferinject®, attribue à l'OFS des prévalences de carence martiale sans publication ; l'audit cite Stoffel 2017 (ETH Zurich) sur l'hepcidine.

Question : Quelle posologie de Ferinject® (dose cumulée selon poids et hémoglobine, dose unique maximale, perfusion, surveillance d'hypersensibilité et d'hypophosphatémie) donne l'AIPS suisse ? Quels sels de fer oraux sont commercialisés en Suisse (Tardyferon®, Maltofer®, Ferro sanol®…) avec leur teneur en fer élémentaire, et quel schéma (quotidien ou un jour sur deux) recommande une source suisse (SSH, Swiss Medical Forum) ? Quelles données suisses chiffrent la prévalence de la carence martiale et de l'anémie ferriprive ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-043 — Haute — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5__export_GoogleDoc.html › D4.3 › point 8 « Diagnostic positif et critères » ; constats L4-M27, L4-M28, L4-M29, L4-M30, L4-M31, L4-M75, L4-L44, L4-L45, L4-L73

Contexte : Le cours fonde le SAOS sur une société américaine, reprend le critère d'observance Medicare (4 h sur 70 % des nuits) comme critère LAMal, attribue une baisse d'IAH au sémaglutide, invoque la LCR sans article et un Epworth ≥ 16 sans source, et présente la stimulation hypoglosse comme recherche ; la V6 a supprimé HypnoLaus.

Question : Quelle recommandation de la Société suisse de pneumologie / Société suisse de recherche sur le sommeil définit le diagnostic et le traitement du SAOS (seuils d'IAH, polygraphie ou polysomnographie) ? Quelles conditions de remboursement fixe la MiGeL en vigueur pour la CPAP (essai, observance exigée) ? Quelle directive suisse encadre l'aptitude à la conduite en cas de SAOS (article LCR/OAC, recommandation de la SSMT) ? Le tirzépatide (Mounjaro®/Zepbound®) a-t-il l'indication SAOS en Suisse ? Quelle prévalence donne HypnoLaus ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :

6. Certitude et réserves :

A-048 — Haute — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › D4.7 › point 5 › critères AEIOU ; constats L4-M47, L4-L23, L4-M50

Contexte : Les seuils des indications de dialyse urgente (pH, kaliémie) et les définitions KDIGO de la MRC (DFGe, ACR) ont disparu à la conversion ; l'audit propose pH < 7,15 et K+ > 6,5 mmol/L d'après KDIGO 2012, à vérifier.

Question : Quels seuils (pH, bicarbonate, kaliémie, surcharge, urémie, intoxications dialysables) définissent l'indication de dialyse en urgence selon KDIGO AKI (version la plus récente) ou une source européenne (ERA) ou suisse (SSN), et quelles valeurs de DFGe et d'ACR définissent et font adresser la MRC selon KDIGO 2024 ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-050 — Haute — LOT 4 · SSP G4

Emplacement : LOT_4_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 1 › point 8 « Diagnostic positif et critères » ; constats L4-M10, L4-M11, L4-M66, L4-M67, L4-M69, L4-L56

Contexte : Le cours attribue à l'OMS des critères de fatigue chronique, assimile le pacing à l'activité physique graduée, fusionne IOM 2015 (6 mois) et NICE NG206 (3 mois) en les disant « adoptés en Suisse », donne 0,3–0,8 % attribué à l'OFSP avec un calcul faux, et prescrit ivabradine, propranolol et midodrine (Gutron®) dans le POTS sans signaler l'usage hors indication.

Question : Existe-t-il une recommandation ou prise de position suisse (OFSP, ASSM, Association ME/CFS Suisse, SSMIG) sur le diagnostic et la prise en charge de l'EM/SFC, avec critères et place de l'activité physique ? Quelle prévalence suisse ou européenne est publiée ? Quelle est l'AIPS de Gutron® (indication, dose, contre-indications) et quelle source européenne recommande les traitements du POTS ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-042 — Moyenne — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2__export_GoogleDoc.html › D4.2 › point 2 « Épidémiologie » ; constats L4-M23, L4-M24, L4-M25, L4-L34, L4-L35, L4-L36

Contexte : Le cours donne une prévalence du burn-out sans source, présente le micro-dosage de psilocybine et Spravato® comme recherche 2026, omet les contre-indications de la sertraline (Zoloft®) et classe mal le PHQ-9.

Question : Quelles données suisses (Job-Stress-Index de Promotion Santé Suisse, Obsan) chiffrent l'épuisement professionnel et la dépression ? Quelles contre-indications, interactions et mises en garde (QT, risque suicidaire < 25 ans, adaptation hépatique) figurent dans l'AIPS de Zoloft® ? Quelles sont les classes validées du PHQ-9 ? Quel est le statut suisse de la psilocybine (usage limité, art. 8 LStup) et de Spravato® en 2026 ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-044 — Moyenne — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5__export_GoogleDoc.html › D4.4 › point 11.D « Recherche 2026 » ; constats L4-M33, L4-L41, L4-L46

Contexte : Le cours présente le génotypage DIO2 et la bithérapie T4/T3 comme validés, qualifie Novothyral® de liothyronine retard, attribue la prévention de la carence en iode à la fluoration et donne un ratio femme/homme 8:1 sans source.

Question : Quelle est la position la plus récente de l'ETA (2012 ou mise à jour) sur la combinaison lévothyroxine-liothyronine et le génotypage DIO2 ? Novothyral® ou une liothyronine sont-ils autorisés en Suisse ? Quelles données suisses chiffrent la prévalence de l'hypothyroïdie et l'iodation du sel ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-045 — Moyenne — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5__export_GoogleDoc.html › D4.5 › point 11.D « Recherche 2026 » ; constats L4-M35, L4-M36

Contexte : Le cours attribue à la SSI des critères de Hoagland et annonce des vaccins ARNm contre l'EBV en phase II/III sans NCT.

Question : Quels critères diagnostiques de la mononucléose infectieuse (clinique, lymphocytose atypique, sérologie VCA/EBNA) recommande une source suisse ou européenne récente ? Quels essais vaccinaux contre l'EBV (NCT, phase) existent en 2026 ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-049 — Moyenne — LOT 4 · SSP G4

Emplacement :
LOT_4_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc.html › D4.8 › point 11.B › fatigue oncologique ; constats L4-M62, L4-M63, L4-M64, L4-L52, L4-L53

Contexte : Le cours prescrit dexaméthasone et méthylphénidate dans la fatigue oncologique sans signaler l'usage hors indication, présente vaccins ARNm et anti-GDF-15 comme routiniers, donne des prévalences sans source et confond les critères IMWG du myélome. L'audit cite ESMO 2020 et Groarke NEJM 2024.

Question : Que recommande la version la plus récente de l'ESMO sur la fatigue liée au cancer (2020 ou ultérieure) : dexaméthasone (dose, durée), méthylphénidate (statut hors indication en Suisse), activité physique ? Quels sont les critères IMWG actuels du myélome (CRAB, SLiM) ? Quel est le stade de développement du ponsegromab (NCT) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-051 — Moyenne — LOT 4 · SSP G4

Emplacement : LOT_4_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 2 › D4.1 à D4.10 › badges de fréquence (10 occurrences) ; constats L4-M09, L4-M14, L4-M15, L4-M16

Contexte : Les badges de fréquence des 10 DX (25 % à 0,5 %) et la prévalence de la fatigue en consultation n'ont aucune source ; la liste des drapeaux rouges est incomplète ; seuls Hb, VGM et ferritine ont un tableau. L'audit cite Stadje BMC Fam Pract 2016.

Question : Quelles études suisses ou européennes de soins primaires chiffrent la fatigue comme motif de consultation et la fréquence de ses causes (anémie, dépression, SAOS, hypothyroïdie, cancer…) ? Quelle recommandation de médecine de famille (SSMIG, DEGAM S3 « Müdigkeit ») fixe le bilan minimal et les drapeaux rouges ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-052 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2__export_GoogleDoc.html › D5.1 › point 11.B › antiviraux › Oseltamivir ; constats L5-M10, L5-M11, L5-M12, L5-M13, L5-L37, L5-L39

Contexte : L'adaptation rénale de l'oseltamivir est fausse, celle du nirmatrelvir/ritonavir manque (relues dans les RCP européens, à confirmer dans l'AIPS) ; le cours affirme un vaccin combiné ARNm grippe/COVID-19 au plan suisse 2026 et des chiffres Sentinella (35 %) sans bulletin.

Question : Quelles adaptations rénales et doses donnent les AIPS suisses de Tamiflu® (oseltamivir) et de Paxlovid® (DFGe, hémodialyse, enfant) ? Quelles indications de traitement antiviral de la grippe et de la COVID-19 recommandent l'OFSP et la SSI en 2026 ? Un vaccin combiné grippe/COVID-19 est-il autorisé par Swissmedic ou recommandé par l'OFSP/CFV ? Quels chiffres Sentinella de la dernière saison donnent les consultations pour syndrome grippal ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-053 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2__export_GoogleDoc.html › D5.2 › Fenêtre 3.2 › tableau › ligne Score ACB ; constats L5-M15, L5-M16, L5-M17, L5-L42, L5-L43, L5-L44, L5-L40, L5-L41

Contexte : Le cours cite Periactin® (cyproheptadine) sans statut suisse vérifié (compendium inaccessible), résume mal les critères de Hunter (texte non relu), attribue 50 % au score ACB ≥ 3, donne un seuil de digoxine probablement en mauvaise unité, des prévalences d'effets indésirables attribuées à « Swissmedic et SSMIG » et un passeport pharmacogénétique suisse 2026 sans source.

Question : La cyproheptadine est-elle autorisée en Suisse (spécialité, importation, recommandation de Tox Info Suisse) et à quelle dose traite-t-on un syndrome sérotoninergique ? Quels sont les critères de Hunter exacts ? Quel est l'intervalle thérapeutique et toxique de la digoxine en nmol/L selon l'AIPS suisse ? Quelles données suisses chiffrent les hospitalisations liées aux effets indésirables médicamenteux et quel est l'état de la pharmacogénétique en Suisse ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-055 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement : LOT_5_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste__export_GoogleDoc.html › Bloc 1 › point 3 › Fenêtre 3.1 qSOFA & NEWS-2 › explicitation ; constats L5-M07, L5-M08, L5-M09, L5-M27, L5-M30, L5-M31, L5-M32, L5-L63, L5-L28

Contexte : Le cours présente le qSOFA comme outil de dépistage, emploie « sepsis sévère », donne des seuils rénaux SOFA faux, cite Fortum® (spécialité suisse : Fortam®), et affirme un triage suisse 2026 par suPAR/MR-proADM et une identification BioFire en < 1 h sans source. L'audit cite la Surviving Sepsis Campaign 2026.

Question : Quelles sont les recommandations les plus récentes (Surviving Sepsis Campaign 2026, recommandations suisses SSMI/SSI ou plan sepsis suisse) sur le dépistage (NEWS2, qSOFA), l'antibiothérapie probabiliste dans l'heure, le remplissage et les vasopresseurs ? Quelle dose de ceftazidime (Fortam®) donne l'AIPS suisse ? Le suPAR, la MR-proADM et les panels moléculaires rapides ont-ils une place recommandée ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-057 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › D5.6 › point 12 Prévention ; constats L5-M35, L5-M36, L5-M38, L5-L75, L5-L76, L5-L78, L5-L81, L5-L82

Contexte : Le cours cite Lipitor® (spécialité suisse : Sortis®), Aspirine Cardio® en IV, des proportions de SCA attribuées à des registres SSC/ESC non identifiés et contradictoires, des délais de coronarographie non lus dans l'ESC 2023 et confond Wellens et de Winter.

Question : Que recommande la version la plus récente de l'ESC sur les syndromes coronariens aigus (2023 ou ultérieure) : dose orale et IV d'acide acétylsalicylique (spécialité IV suisse, p. ex. Aspégic®), délais de coronarographie (immédiate, < 24 h, sélective), aspects ECG à haut risque (Wellens, de Winter) ? Quelles données du registre suisse AMIS Plus décrivent la répartition STEMI/NSTEMI et la mortalité ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-058 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7__export_GoogleDoc.html › D5.7 › Fenêtre 3.7 › explicitation des critères ; constats L5-M33, L5-M39, L5-M40, L5-L77, L5-L83, L6-M16

Contexte : LOT_5 (D5.7) présente les critères ACR 1990 sous l'étiquette ACR/EULAR 2022, attribue 70 % de rémission au tocilizumab en 1re ligne, cite Mepram® (non retrouvé) et une incidence sans source. LOT_6 (D6.8 › point 9) ne dit pas que la corticothérapie précède la biopsie ; l'audit cite EULAR 2018 (prednisone 40–60 mg/j, bolus de méthylprednisolone).

Question : Que recommande la version la plus récente de l'EULAR sur les vascularites des gros vaisseaux (2018 ou mise à jour) pour l'artérite à cellules géantes : dose initiale de prednisone, bolus IV en cas de perte visuelle, délai de la biopsie ou de l'échographie, décroissance, place du tocilizumab (indication et limitation suisses, résultats GiACTA) et prophylaxie gastrique ? Quelle incidence européenne est publiée ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

A-059 — Haute — LOT 5 · SSP G5

Emplacement :
LOT_5_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10__export_GoogleDoc__v2.html › D5.9 › point 11.B.2 › Endocardite à Staphylococcus aureus ; constats L5-M45, L5-M47, L5-L97, L5-L98, L5-L99, L5-L104, L5-L102, L6-M24

Contexte : Le cours associe un aminoside à l'endocardite staphylococcique sur valve native, cite Orbénine® (spécialité française ; en Suisse Floxapen®), mélange les schémas streptococciques de 2 et 4 semaines, annonce des « scores d'Eichhorn » et une ESC « 2025 » introuvables, présente la phagothérapie comme établie et donne une incidence suisse sans source. LOT_6 (D6.6 › point 12) ne nomme ni patients à haut risque ni schéma de prophylaxie ; l'audit cite Sendi et al., Swiss Med Wkly 2021 (SSI/SSC) et l'ESC 2023.

Question : Quels schémas antibiotiques recommande la version la plus récente de l'ESC sur l'endocardite (2023 ou ultérieure) : streptocoques (2 ou 4 semaines, critères), Staphylococcus aureus sur valve native et prothèse (flucloxacilline, rifampicine, gentamicine) ? Quelle dose de flucloxacilline (Floxapen®) donne l'AIPS suisse ? Quelle est l'incidence de l'endocardite en Suisse et quel essai de phagothérapie existe (NCT) ? La recommandation suisse de prophylaxie de l'endocardite (Sendi 2021) a-t-elle été mise à jour, et diffère-t-elle de l'ESC 2023 (patients à haut risque, gestes, amoxicilline 2 g, alternative en cas d'allergie) ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P07 — 16 questions : A-040, A-041, A-043, A-048, A-050, A-042, A-044, A-045, A-049, A-051, A-052, A-053, A-055, A-057, A-058, A-059